

2A. Rodilla: anamnesis dirigida

Distinguir artrosis mecánica, derrame/inflamación, menisco, dolor femoropatelar, tendón y dolor referido de cadera.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Le duele al caminar, subir escaleras o levantarse y tiene rigidez matutina menor de 30 minutos?	Artrosis mecánica probable.	Reduce el patrón típico de OA sintomática.	Marcha, alineación, ROM, crepitación y RX en carga si cambia conducta.
¿Se le ha hinchado rápidamente, está caliente, tiene fiebre o duele incluso sin moverla?	Infección, cristales, hemartros o sinovitis activa.	Reduce urgencia inflamatoria, sin eliminarla.	Temperatura, derrame y artrocentesis/analítica según contexto.
¿Comenzó tras un giro y nota dolor en la interlínea, enganche o bloqueo verdadero?	Lesión meniscal mecánicamente relevante.	Reduce menisco mecánico; no excluye lesión degenerativa incidental.	Interlínea, McMurray/Thessaly y extensión completa.
¿Le duele por delante al bajar escaleras, ponerse en cuclillas o tras estar sentado?	Dolor femoropatelar.	Reduce patrón femoropatelar.	Step-down, sentadilla, control de cadera y rótula.
¿El dolor está exactamente en el tendón y aparece al saltar, correr o extender la rodilla?	Tendinopatía rotuliana o cuadricepsal.	Reduce tendón como generador principal.	Palpación, carga resistida y ecografía concordante.
¿Nota inestabilidad o que la rodilla se le va desde un traumatismo?	Lesión LCA/LCP/colaterales o inestabilidad funcional.	Reduce inestabilidad sintomática.	Lachman, sag/cajón posterior y valgo/varo.
¿También le duele la ingle, cojea o le cuesta ponerse el calcetín?	Dolor referido desde cadera.	Reduce cadera, pero no excluye hip-spine.	Rotación interna, FADIR/FABER y marcha.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

Antes de infiltrar, una rodilla caliente o un derrame agudo sin explicación obliga a descartar infección, cristales o hemartros. El dolor medial puede proceder de la cadera.

2B. Rodilla: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Stroke / bulge	Con rodilla extendida, vaciar líquido medial hacia suprapatelar y barrer lateral hacia medial.	Onda/abombamiento medial: derrame pequeño.	Reduce derrame pequeño; no excluye mínima sinovitis.
Baloteo rotuliano	Comprimir receso suprapatelar y empujar rótula hacia fémur.	Rótula flota o golpea fémur: derrame moderado-grande.	No excluye derrame pequeño; usar stroke test.
McMurray + interlínea	Flexionar rodilla; rotar tibia y aplicar varo/valgo mientras se extiende, palpando interlínea.	Dolor habitual o clic palpable en interlínea: aumenta sospecha meniscal si la historia concuerda.	No descarta lesión meniscal; pesa más si tampoco hay bloqueo ni dolor focal.
Thessaly	Apoyo monopodal, rodilla a unos 20°; girar cuerpo/rodilla varias veces con apoyo.	Dolor de interlínea, catching o bloqueo: apoya menisco.	Rendimiento modesto; negativo no excluye. Evitar si dolor intenso/inestabilidad.
Lachman	Rodilla 20°-30°; estabilizar fémur y traccionar tibia hacia delante.	Mayor traslación y tope blando frente al lado sano: insuficiencia LCA.	Buen tope reduce rotura completa; no excluye parcial, dolor o defensa.
Sag + cajón posterior	A 90° observar caída posterior tibial; después empujar tibia hacia atrás.	Sag o traslación posterior aumentada: insuficiencia LCP.	Reduce rotura completa; lesiones parciales pueden pasar inadvertidas.
Valgo / varo	Aplicar estrés valgo y varo a 30° y repetir cerca de 0°.	Dolor/laxitud a 30°: colateral; laxitud a 0°: posible lesión multiligamentaria.	Estabilidad reduce lesión significativa; no excluye esguince leve doloroso.
Step-down / sentadilla	Descenso de escalón o sentadilla monopodal observando dolor, valgo y control pélvico.	Dolor anterior habitual y mal control: apoya dolor patelofemoral y déficit funcional.	No excluye patelofemoral; es prueba funcional, no de una estructura única.

SÍNTESIS CLÍNICA

Menisco: ninguna prueba aislada confirma; combinar historia de giro/bloqueo, interlínea y maniobras. Ligamentos: comparar siempre con el lado sano. Rodilla caliente o derrame agudo sin causa clara exige pensar antes en infección, cristales o hemartros.

2C. Rodilla: ecografía, derrame e infiltraciones

El color ámbar o seroso no excluye infección ni cristales: la indicación de análisis depende del contexto clínico.

Plantilla ecográfica básica normal	Qué documentar
Receso suprapatelar	Sin derrame significativo ni hipertrofia sinovial/hiperemia patológica.
Tendón cuadricipital y rotuliano	Continuidad, patrón fibrilar y grosor conservados; sin Doppler patológico.
Compartimento medial/lateral	Interlíneas, menisco periférico visible, extrusión, MCL/LCL y osteofitos.
Región anterior	Grasa de Hoffa, retináculos y recesos parapatelares según clínica.
Huevo poplíteo	Sin quiste de Baker ni colección; vasos identificados.
Limitación	La ecografía no excluye lesión intraarticular profunda ni sustituye RM cuando está indicada.

Decisión	Regla práctica	Expectativa realista
Artrocentesis	Medir volumen/aspecto; si infección/cristales posibles: recuento, cristales, Gram y cultivo. Documentar p. ej. "7 cc, amarillo-ámbar, transparente/turbio".	El aspecto orienta, no diagnóstica.
Corticoide IA	Puede aliviar a corto plazo una OA sintomática/sinovitis; individualizar diabetes, infección, cirugía próxima y repetición.	Semanas en muchos pacientes; no prometer duración.
Ácido hialurónico	No recomendado de rutina por AAOS/NICE; si se ofrece, explicar beneficio medio pequeño/incierto y coste.	No prometer 6-12 meses.
PRP	Puede mejorar dolor/función en algunos fenotipos de OA, pero evidencia/calidad y preparaciones heterogéneas.	No afirmar superioridad universal ni excluir solo por "avanzada" sin contexto.
Bloqueo genicular → RF	OA crónica refractaria, cirugía no indicada/rechazada o dolor persistente seleccionado; bloqueo pronóstico según protocolo.	Objetivo analgésico/funcional, no modificar artrosis.

PLAN BASE	Ejercicio de fuerza y aeróbico adaptado, pérdida de peso si procede, educación y AINE tópico como opción inicial en OA de rodilla. Fisioterapia 6-12 semanas con reevaluación funcional; ESWT se reserva para tendinopatías seleccionadas, no para la artrosis intraarticular. EMTT/inductiva: complemento opcional de evidencia limitada/emergente.
------------------	--

MENSAJE AL PACIENTE	La punción puede bajar el dolor y el derrame, pero la rodilla mejora de forma más duradera cuando usamos esa ventana para fortalecer, caminar mejor y reducir la carga total sobre la articulación.
----------------------------	---

2D. Rodilla: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
OA periférica	Diclofenaco gel 11,6 mg/g; 2-4 g, 3-4 veces/día.	7-14 días; puede prolongarse 2-4 semanas si eficaz y seguro.
Brote doloroso	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h; añadir omeprazol 20 mg/día si riesgo GI.	5-7 días; no combinar AINE.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días; retirar si no aporta.
OA con fenotipo central	Duloxetina 30 mg/día 1-2 semanas; después 60 mg/día si tolera.	Ensayo 6-8 semanas; continuar solo si mejora dolor y función.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Artrocentesis + corticoide	Tras aspirar: betametasona depot 1 mL o triamcinolona 40 mg + lidocaína 1%/bupivacaína 0,25%.	Total 3-5 mL; no infiltrar hasta excluir infección cuando proceda.
Bloqueo diagnóstico IA	Lidocaína 1% o bupivacaína 0,25%, sin corticoide.	3-5 mL; repetir tarea a los 15-30 min.
Ácido hialurónico	Preparado comercial específico; no mezclar ni extrapolar dosis entre productos.	Habitualmente 2-6 mL según ficha técnica; no rutinario.
PRP	PRP autólogo según sistema validado; no mezclar con anestésico local ni corticoide.	Habitualmente 4-6 mL; protocolo y evidencia variables.

REHABILITACIÓN

Fuerza de cuádriceps y cadera, ejercicio aeróbico y control de peso/carga durante 8-12 semanas; fisioterapia 4-8 sesiones si requiere supervisión.

EVITAR

Infiltrar una rodilla caliente sin estudio, prometer 6-12 meses de respuesta, repetir corticoide por calendario o confundir PRP con regeneración de cartílago.